

＋ 血管外漏出時の対応 (抗癌剤) ＋

血管外漏出を疑う症状

初期症状

滴下速度が遅くなる
滴下しない
血液の逆流が確認できない
違和感
発赤
紅斑
腫脹

炎症進行に伴う症状

水疱形成
硬結
潰瘍
壊死

上記症状があり、漏出を疑った場合

注射ないし点滴を止め、直ちに医師に報告

留置針から薬剤と血液を3～5ml程吸引してから抜去

潰瘍や壊死に進行する恐れのあるケースにはステロイド剤と局所麻酔剤の皮下注射が医師により行なわれることもある。

ビンアルカイド系は温罨法
(薬剤の分散・吸収)

多くの抗癌剤は、漏出した患肢を心臓より上に挙上し、冷罨法(24時間～48時間)
(薬剤の拡散防止・消炎用)

漏出薬剤の種類・漏出量及び対応をカルテ・看護記録に記載

漏出部経過観察

壊死を起こす可能性のある薬剤は潰瘍形成の深さや広がりがもっともひどくなるのは、**漏出後2～3週間後**であるとされている。その間の観察は必要。

皮膚潰瘍形成の兆候が認められるときは、直ちに皮膚科、形成外科へコンサルテーション